

大腸癌:薬剤師の実践ポイント

経口薬の服用管理・相互作用・自宅での副作用フォロー

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ☐ カペシタビン・FTD/TPI・レゴラフェニブの服用日と残薬の管理
- ☐ ワルファリン等の併用薬、市販の下痢止め・サブリの確認
- ☐ 電話フォローで下痢・発熱・ポンプ抜針後の状況を確認
- ☐ 手足症候群・皮疹のスキンケア指導と外用薬の使い方
- ☐ 症状をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ

病院薬剤師

- ☐ RAS/BRAF/MSI・UGT1A1の結果とレジメンの整合性の監査
- ☐ オキサリプラチン・イリノテカンの投与量と前投薬の確認
- ☐ 携帯型ポンプ(5-FU持続静注)の準備と使い方の説明
- ☐ 周術期の抗VEGF薬の休業期間の管理
- ☐ お薬手帳へのレジメン情報・投与日の記載

病院と共有する情報

バイオマーカー・レジメン

検査値

下痢・手足症候群のGrade

服用状況・家庭血圧

2 主なレジメンと薬局での確認ポイント

レジメン	構成・投与スケジュール	周期	薬局での確認ポイント
mFOLFOX6	オキサリプラチン+レボホリナート+5-FU急速静注 → 5-FU 46時間持続静注	2週毎	携帯型ポンプの管理・抜針日、寒冷刺激による急性しびれ
CAPOX	オキサリプラチン(1日目)+カペシタビン 1日2回 1~14日目 内服	3週毎	内服日数と休業期間、手足症候群、ワルファリン併用時のINR
FOLFIRI	イリノテカン+レボホリナート+5-FU急速静注 → 46時間持続静注	2週毎	遅発性下痢時の下痢止めの使い方、UGT1A1、脱毛
FTD/TPI	トリフルリジン・チピラシル 1日2回 1~5日目・8~12日目 内服(土ペバシズマブ)	4週毎	食後服用(空腹時は吸収が増え好中球減少が増強)、骨髄抑制
レゴラフェニブ	1日1回 1~21日目 内服(低用量から漸増する方法も)	4週毎	低脂肪食後に服用、手足症候群、投与初期2か月の肝機能・血圧

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サブリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書 併用禁忌	S-1 DPD阻害(ギメラシル)	処方薬 他のフッ化ピリミジン系(カペシタビン・5-FU等)	5-FU濃度↑ → 重篤な骨髄抑制・下痢	切り替え時は7日以上空ける
注意 添付文書 警告・併用注意	カペシタビン・S-1 CYP2C9の抑制	処方薬 ワルファリン・フェニトイン	INR↑(出血)・フェニトイン中毒	INR測定の頻度を処方医と確認
注意 添付文書 併用注意	レゴラフェニブ CYP3A4阻害・誘導	処方薬 クラリスロマイシン・アゾール系・リファンピシン	副作用↑・効果↓	他院の抗菌薬・抗真菌薬の処方を確認
注意 添付文書 用法	レゴラフェニブ 食事で吸収が変化	生活習慣 空腹時・高脂肪食後の服用	効果減弱のおそれ	低脂肪の食事の後に服用するよう指導
注意 添付文書 用法	FTD/TPI 空腹時は吸収が増加	生活習慣 空腹時の服用	好中球減少が増強	朝・夕の食後に服用するよう指導
確認 服薬指導上の注意	イリノテカン(遅発性下痢) 過量・症状を隠す	市販薬 市販の下痢止め	脱水・感染性腸炎の見逃し	下痢止めの使用量と回数、発熱の有無を確認

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前

「冷たい物に触れると、指先やのどがピリッとすることがあります。手袋や常温の飲み物で予防しましょう」

確認:お薬手帳でRAS/BRAF/MSI・UGT1A1、併用薬(ワルファリン・フェニトイン)

△ ワルファリン併用中はINR測定の予定を確認

投与後~5日

「水のような下痢が続く時は、お渡しした下痢止めを指示どおりに。回数が1日4回以上増えたら連絡を」

確認:電話フォローで下痢の回数・水分量、携帯型ポンプの抜針

△ 水様便が止まらない・発熱を伴う時は至急連絡

投与後1~2週

「37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずに、すぐ病院へ連絡してください」

確認:電話フォローでnadir期の発熱・口内炎、カペシタビンの服用日数

△ 発熱・悪寒はFNを疑い夜間休日でも受診

次回来局時

「手足の赤みや痛み、ボタンが留めにくいなどの変化はありませんか」

確認:手足症候群・しびれのGrade、家庭血圧・尿蛋白、皮疹

△ Grade2以上はトレーシングレポートで共有